

Vortrag: Abgabe / Erwerb einer Kassenzulassung – Möglichkeiten und Restriktionen

Autor(en): S. Haniffa, München [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: Berater (B):	Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)
[2]: Eigentümer (E):	Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)
[3]: Investor (I):	Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, Anteilseigner etc.)
[4]: Mitarbeiter (M):	Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (Mitarbeiter des Produktherstellers)
[5]: Produkt (P):	Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)
[6]: Keine (K):	Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

Abgabe / Erwerb einer Kassenzulassung

Stephan Haniffa, Teamleiter Präsenzberatung Süd

KVB
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

München, 17.03.2018



Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB)



- Servicepartner und Dienstleister für Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeuten und Patienten in Bayern
- größte Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands mit ca. 24.000 Mitgliedern
- Betreut ihre Mitglieder mit ca. 1.600 Beschäftigten serviceorientiert und zuverlässig
- Verteilt Honorar für ihre Mitglieder in Höhe von ca. 5,5 Mrd. Euro
- Mitglieder sichern die ambulante ärztliche Versorgung von mehr als 12 Mio. Bürgern im Freistaat

Möglichkeiten der Praxisabgabe

Verkauf der Praxis an einen neu zuzulassenden Arzt

Verkauf der Praxis an einen Job-Sharing Partner

Einstellung der Tätigkeit ohne Nachfolger

Verkauf der Praxis an ein Medizinisches Versorgungszentrum

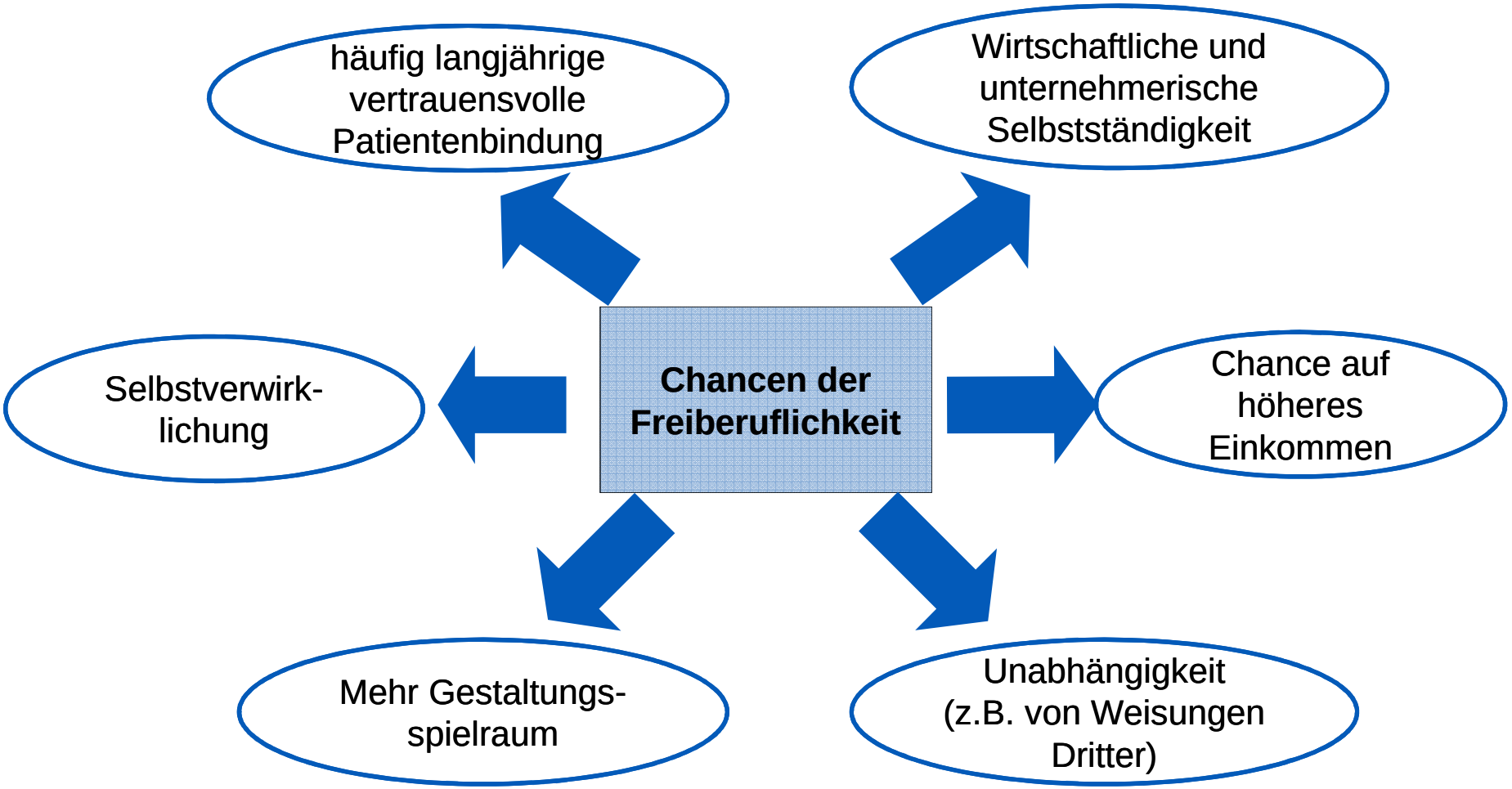
Abgabe der Praxis an einen Kollegen und Weiterarbeit als Angestellter

Fusion mit einem Vertragsarzt zum Zwecke der Weiterverwertung des Sitzes durch Hereinnahme eines Partners

Abgabe der Praxis in ein medizinisches Versorgungs-zentrum und Weiterarbeit als Angestellter

Freiberuflichkeit I

Chancen



Bedarfsplanung: Versorgungsebenen seit 01.01.2013

KVB Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Hausärztliche Versorgung	Fachärztliche Versorgung		
	Allgemeine Fachärztliche Versorgung	Spezialisierte Fachärztliche Versorgung	Gesonderte Fachärztliche Versorgung
Mittelbereiche *)	**Kreise** (kreisfreie Städte, Landkreise, Kreisregionen) (**5 Kreistypen**)	**Raumordnungsregionen**	**KV-Bezirk**
Allgemeinärzte **Praktische Ärzte** **Hausärztliche Internisten**	**Augenärzte** **Chirurgen** **Frauenärzte** **HNO-Ärzte** **Hautärzte** **Nervenärzte** **Orthopäden** **Urologen** **Psychotherapeuten** **Kinderärzte**	**Anästhesisten** **Radiologen** **Fachinternisten** **Kinder- und Jugendpsychiater**	**Physikalische und Reha-Mediziner** **Nuklearmediziner** **Strahlentherapeuten** **Neurochirurgen** **Humangenetiker** **Laborärzte** **Pathologen** **Transfusionsmediziner**

***) zum Teil weiter aufgespalten!**

Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen

Versorgungsgrad/Zulassungsbeschränkung

1. • Festlegung Allgemeiner Verhältniszahlen (= **Arzt/Einwohnerrelation**) je Arztgruppe
2. • je nach Einwohnerzahl in einem Planungsbereich (PB) ergibt sich daraus eine bedarfsplanerische Norm-Anzahl an Ärzten je Fachrichtung in einem PB = **allgemeiner bedarfsgerechter Versorgungsgrad** (VG) **von 100%**
3. • wenn das **Verhältnis** von „tatsächlichem lokalem VG“ zu „allgemeinem bedarfsgerechtem VG“ in einem PB je Arztgruppe:

= kleiner 110 %	= größer/gleich 110 %
• **PB mit begrenzter Zulassungsmöglichkeit bzw. partiell entsperrt!**	• **PB gesperrt!**
• **Teilzulassung/Zulassung** und **Anstellung** bei Vertragsarzt/BAG/MVZ möglich im Umfang der ausgewiesenen Stellen!	• **Teilzulassung/Zulassung** nur im Rahmen einer Praxissitzübernahme und **Anstellung** bei Vertragsarzt/BAG/MVZ nur mittels Nachbesetzung einer vorhandenen Angestelltenstelle möglich! Ausnahmen: Sonderbedarfszulassung/-anstellung
	• Bei Praxissitzübernahme: formelles Nachbesetzungs-/Ausschreibungsverfahren notwendig!!!

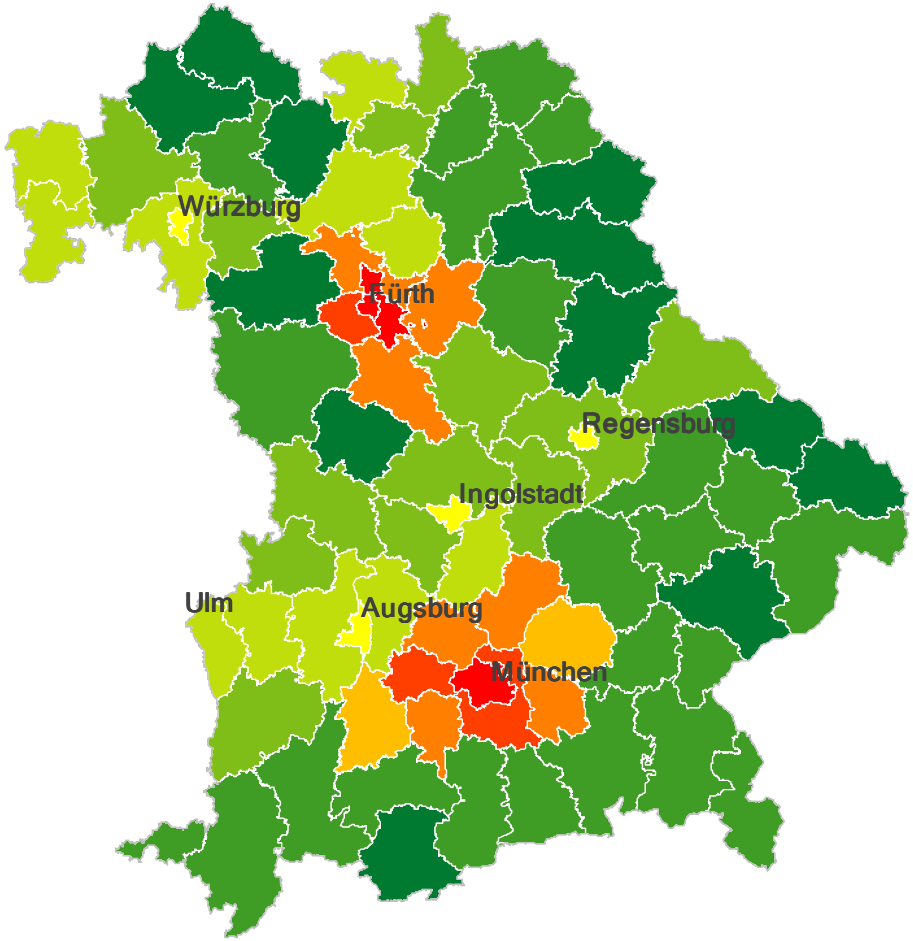


Bei Job-Sharing-Zulassung bzw. -**Anstellung** u. **Belegarztzulassung** spielt die Bedarfssituation generell keine Rolle!

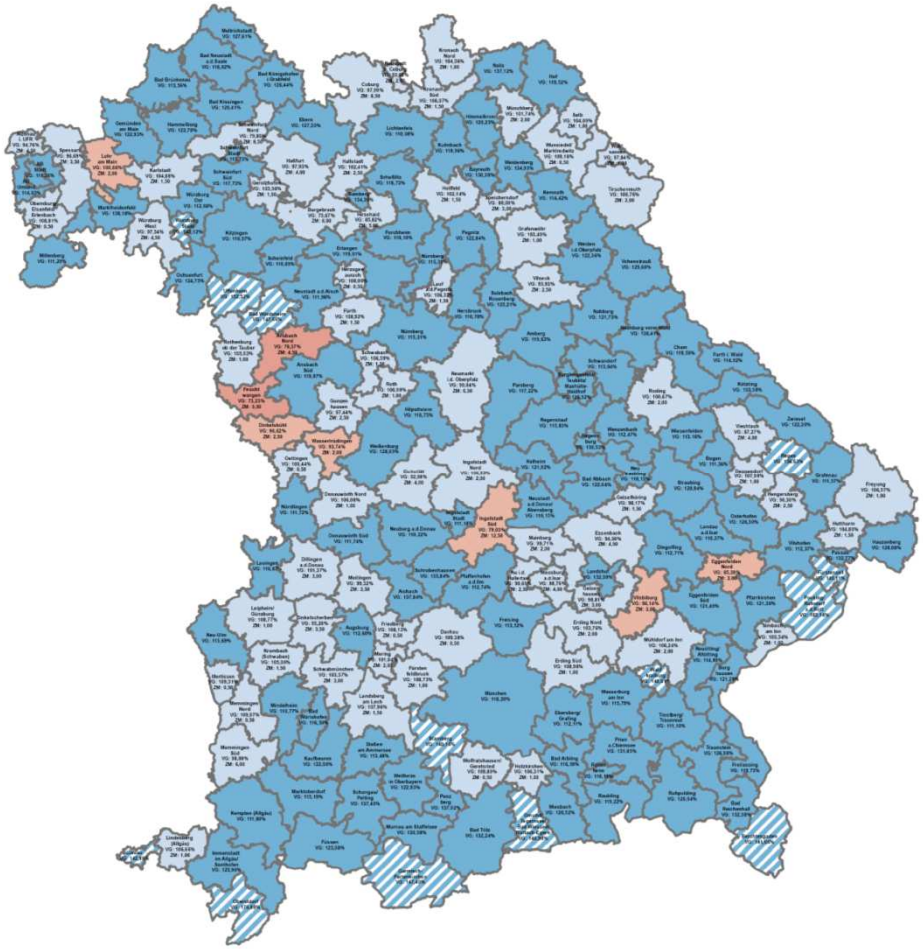
Foto: Getty Images

Bedarfsplanung: Planungsbereiche neu - hausärztliche Versorgung

79 Stadt-/Landkreise, Kreisregionen

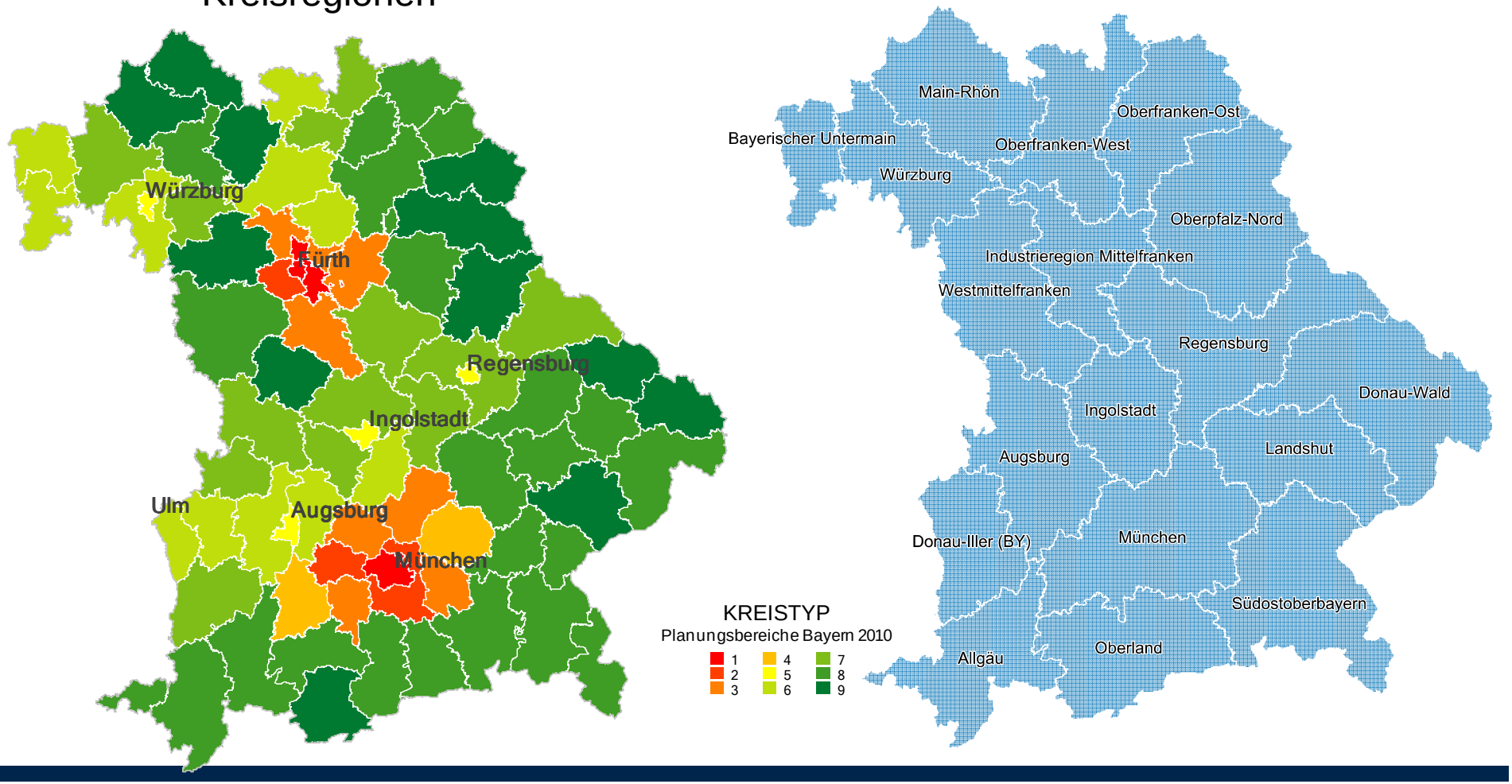


über 200 Mittelbereiche



Bedarfsplanung: Planungsbereiche neu - spezialisierte fachärztliche Versorgung

79 Stadt-/Landkreise, Kreisregionen → 18 Raumordnungsregionen



Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen

2-stufiges Antragsverfahren für Systemzugang

Approbation
+
Facharzt-anerkennung

Antrag

Arztregister



KV des Wohnorts

Antrag

Zulassung, Anstellung, Ermächtigung



Foto: iStockphoto.com

Zulassungsausschuss des Praxissitzes

notwendig für:
- **alle Formen der Zulassung**
- **alle Formen der Anstellung nach SGB V**

notwendig für:
- **alle Formen der Zulassung**
- **alle Formen der Anstellung nach SGB V**
- **Ermächtigung**

Teilnahmeformen

Assistenz
- Weiterbildungsassistent
- Sicherstellungsassistent

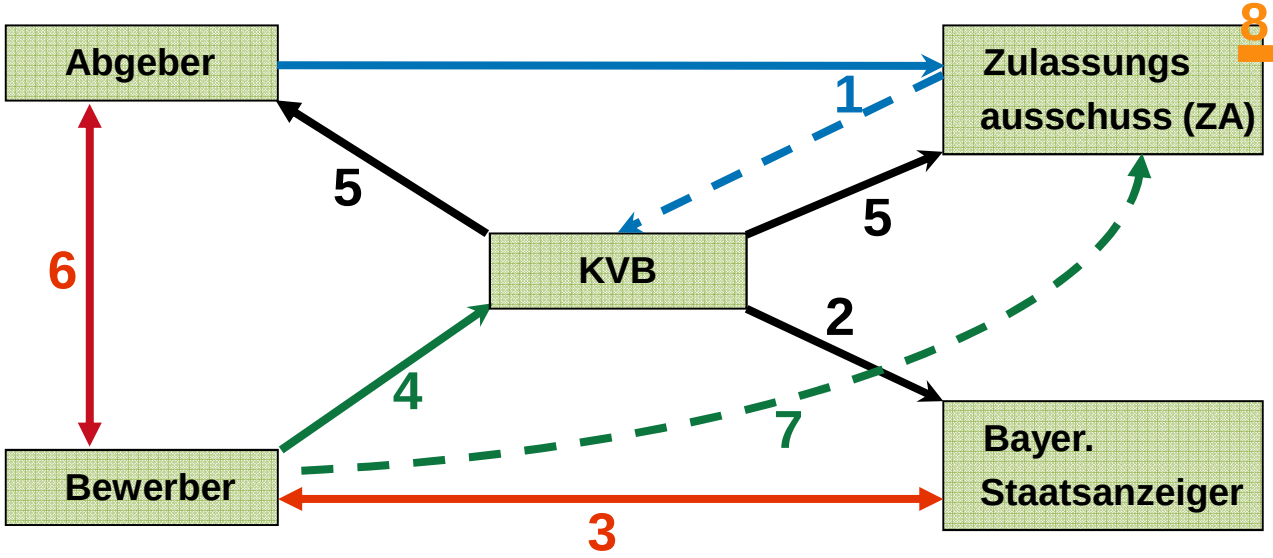
Anstellung
- ¼, ½, ¾, Vollzeit
- bei einem Vertragsarzt
- im MVZ
- „Jobsharing-Anstellung“

Zulassung
- volle Zulassung
- halbe Zulassung
- Jobsharing - Zulassung

Ermächtigung

Vertretung

Nachbesetzungs-/Ausschreibungsverfahren + Bewerberauswahl



Bewerberauswahlverfahren § 103(4) SGB V:

- berufliche Eignung
- Approbationsalter
- Dauer ärztl./psychotherapeut. Tätigkeit ****)**
- mind. 5 J. Tätigkeit in unterversorgtem Gebiet
- Bewerber ist Ehegatte, Partner oder Kind des bisherigen VA
- Bewerber ist angestellter Arzt des bisherigen VA oder BAG-Partner der Praxis
- Bewerber ist bereit, definierte besondere Versorgungsbedürfnisse zu erfüllen
- Belange von Behinderten beim Zugang zur Versorgung
- ggf. Ergänzung des besonderen Versorgungsangebotes eines MVZ
- Dauer der Eintragung in Warteliste

1	seit 2013: Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungs-/Ausschreibungsverfahrens an den ZA/(ggf. weiter an KVB)	**5**	Info über Bewerber von KVB an Abgeber und ZA
2	ggf. dann öffentliche Ausschreibung durch KVB im Bayer. Staatsanzeiger	**6**	Privat-Verhandlungen zwischen Abgeber und Übernehmer (z.B. Kaufpreis, Vertrag)
3	Kenntnisnahme der Ausschreibung im Bayer. Staatsanzeiger durch Bewerber	**7**	Zulassungsantrag des Bewerbers an den ZA
4	(formlose) Bewerbung auf die Ausschreibung an KVB durch Bewerber *)	**8**	Bewerberauswahlverahren beim ZA gem. § 103 Abs. 4 SGB V

***)** Alternativ: formgebundener Zulassungsantrag an die Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses. Die Einreichung eines formgebundenen Zulassungsantrags an die Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses ist in jedem Falle – auch bei vorheriger formloser Ausschreibungsbewerbung – notwendig.

****)** Wird ggf. verlängert um Zeiten der Unterbrechung der ärztl. Tätigkeit wg. **Kindererziehung** oder **Pflege naher Angehöriger in häuslicher Umgebung!**

Umwandlung einer Anstellung nach § 95 Abs. 9 S. 1 SGB V

in eine Zulassung/Teilzulassung

Antrag des VA auf Umwandlung der genehmigten Anstellung in eine Zulassung **mit dem bisher angestellten Arzt** als Inhaber der Zulassung

Antrag des VA auf Umwandlung der genehmigten Anstellung in eine Zulassung und auf Ausschreibung des Vertragsarzt-sitzes zur Nachbesetzung **mit anderem Arzt** (im gesperrten PB)

Voraussetzungen:

> Umfang der genehmigten und ausgeübten Anstellungs-Tätigkeit **mind. 40 (für Vollzulassung)** bzw. **mind. 20 Wochenstunden (für Teilzulassung)**; ggf. vorheriger Antrag auf Erhöhung der Stundenzahl auf 40 bzw. 20 Wochenstunden und Ausübung über mind. 1 Quartal

> Umwandlung erst, wenn angestellter Arzt mind. 1 Quartal tätig war

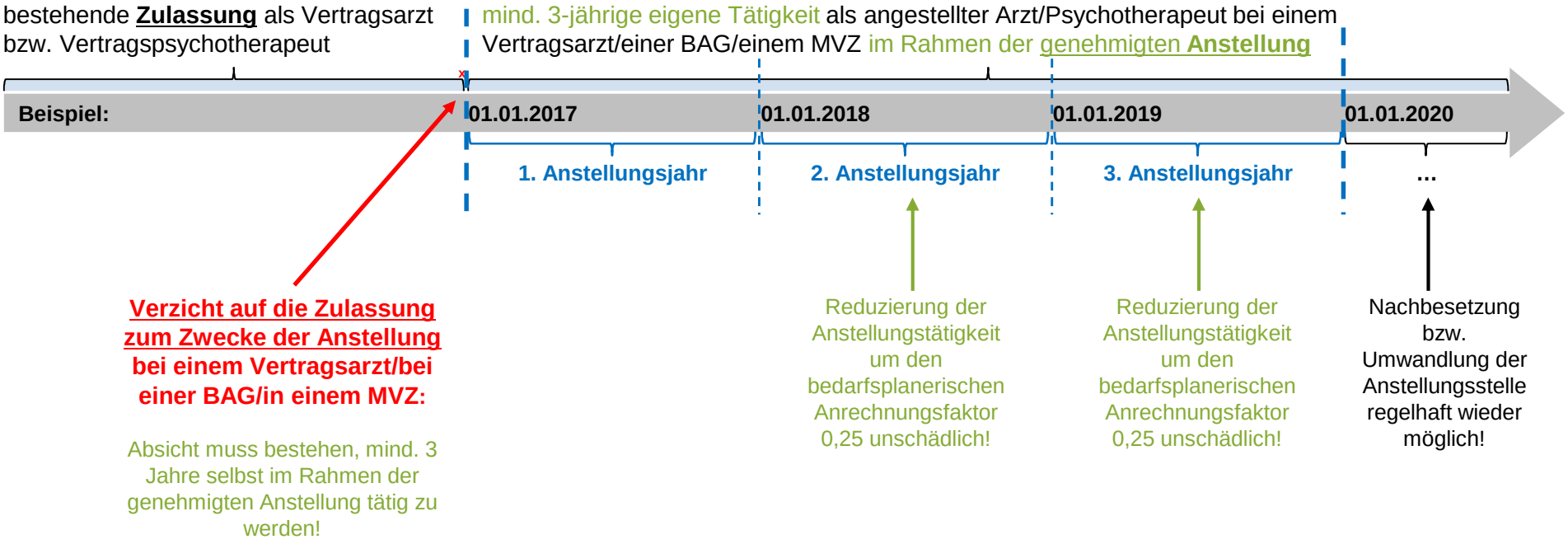
> Umwandlung spät. innerhalb von 6 Monaten nach ggf. einer Beendigung der Anstellung

> sog. „Teilverwertung“ (Teilumwandlung) prinzipiell möglich (-> vorher beraten lassen, damit kein Anrechnungsfaktor „verloren“ geht!)

> im Falle der Ausschreibung: keine Versorgungsrelevanzprüfung gemäß § 103 Abs. 3a SGB V

Einbeziehung von Kooperationsmöglich-keiten in die Planung der Praxisabgabe II

„3-Jahres-Urteil“ des BSG vom 04.05.2016 - B 6 KA 21/15 R – Achtung, unter Vorbehalt!



Weitere Anstellungs-Optionen

… durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

- **gleichzeitige Tätigkeit als Vertragsarzt und als angestellter Arzt**
  (z.B. parallele Anstellung im Krankenhaus, im MVZ, bei anderem Vertragsarzt)
- Mitteilung an Zulassungsausschuss

Nebentätigkeitsgrenzen bei Zulassung

ca. **13 Stunden/Woche** bei Vollzulassung

ca. **26 Stunden/Woche** bei Teilzulassung



- **Doppel-Anstellung**
  - bei Vertragsarzt und im Krankenhaus
  - im MVZ und im Krankenhaus
  - **…**

Arbeitszeitgesetz beachten - für einen Arbeitnehmer grundsätzlich
(= durchschnittlich) **48 Stunden/Woche**!



Zulassung versus Anstellung

Kennzeichen Zulassungsstatus		Kennzeichen Anstellungsstatus
Vertragsarztstatus	⟺	kein Vertragsarztstatus
Freiberuflichkeit	⟺	Angestellter
Selbständigkeit	⟺	abhängige Beschäftigung
Tätigkeit in eigener freier Praxis	⟺	Tätigkeit beim Unternehmer
Unternehmer	⟺	kein Unternehmer
Kapitaleinsatz	⟺	kein Kapitaleinsatz
Träger des wirtschaftlichen Risikos	⟺	kein wirtschaftliches Risiko
Umsatz-/Gewinnerzielung	⟺	festes Gehalt

In der ambulanten Versorgung als angestellter Arzt/angestellte Ärztin zu arbeiten ist im wesentlichen geprägt vom Wunsch nach Teilzeittätigkeit und Risikoreduzierung!

Die Zukunft liegt in der Kooperation!

Praxiserweiterung
Filiale
Anstellung
Jobsharing - Anstellung

lose Kooperationsformen
Praxis- / Apparategemeinschaft
Ärztehaus
Praxisnetze


Foto: Getty Images


Foto: Jupiter Images Corporation

feste Kooperationsformen
Gemeinschaftspraxis (überörtlich)
Teilgemeinschaftspraxis (überörtlich)
Jobsharing - Zulassung
MVZ

sektorübergreifende Kooperationen
konsiliarärztliche Tätigkeit
Belegarzttätigkeit
Bereitschaftspraxis

Chancen der Kooperation III

Einsparmöglichkeiten v. a. in den Bereichen

- Personal,
- Raum und
- med. technisches Gerät:

Einfaches Zahlenbeispiel

Kosten Einzelpraxis p. a.:	
2 Arzthelferinnen (à 25 Tsd. €)	50,0 Tsd. €
+ Miete für 140 m²	25,2 Tsd. €
+ Wartungskosten	5,0 Tsd. €
Summe	80,2 Tsd. €

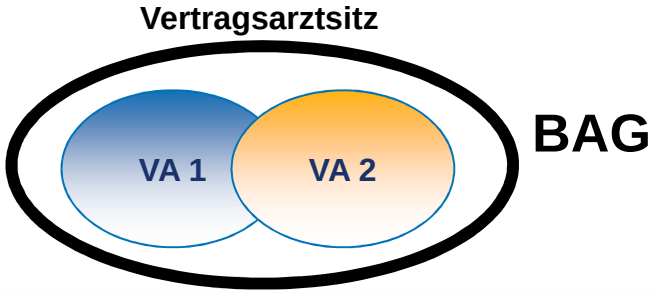
Kosten Gemeinschaftspraxis p. a.:	
3 Arzthelferinnen (à 25 Tsd. €)	75 Tsd. €
+ Miete für 250 m²	45 Tsd. €
+ Wartungskosten	5 Tsd. €
Summe	125 Tsd. €

Kosten je Arzt 80,2 Tsd. € vs. Kosten je Arzt 62,5 Tsd. €

➡ Chance auf Ertragssteigerungen

(örtliche) Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)

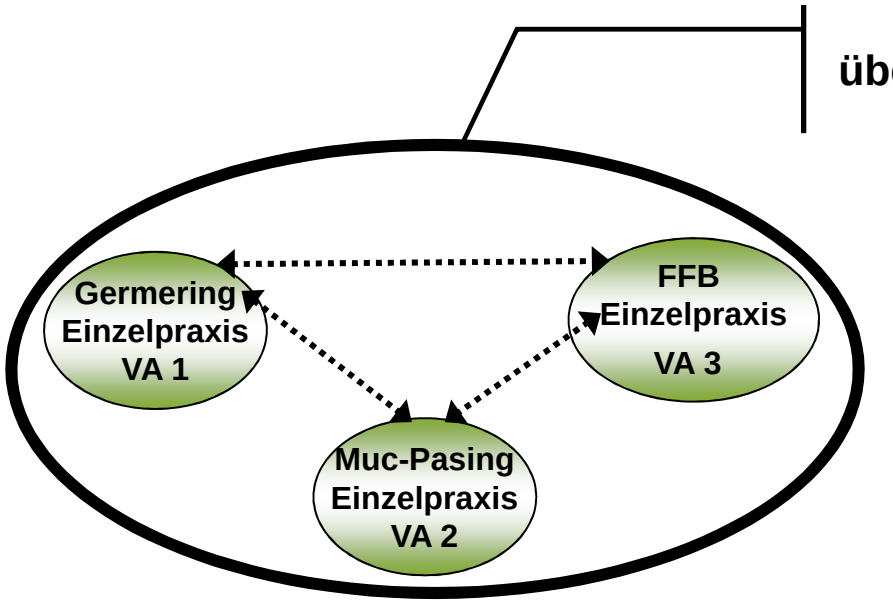
- Gesellschaftszweck: gemeinsame Berufsausübung an einem **gemeinsamen Vertragsarztsitz**, gemeinsamer Behandlungsvertrag, gemeinsame Inanspruchnahme von Ressourcen**,** gemeinsamer Patientenstamm, gemeinsames Praxisbudget, ein Honorarbescheid/-konto, gemeinsames Praxisschild
- fachgleich und fachübergreifend möglich (Spezialfall: Job-Sharing-BAG ⇨ Fachidentität!)
- zwischen allen zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassenen Leistungserbringern (Ärzte, MVZ, PP, KJP) möglich; Genehmigung durch ZA



➡ Einschränkung durch Berufsrecht:
BAG nur zwischen Ärzten und ärztl. geleiteten MVZ, die als BGB- o. Partnerschaftsgesellschaft geführt werden und bei denen ausschließlich Ärzte Gesellschafter bzw. Partner sind!

- schrittweiser finanzieller Einstieg möglich!
- bei „**Nullbeteiligung**“ Gefahr, dass Scheinselbständigkeit vermutet wird (= verdecktes Anstellungsverhältnis) ⇨ entsprechende Vertragsgestaltung notwendig!
- Haftungsrisiko für Altverbindlichkeiten bei GP-Einstieg!

überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)



Wahl eines Hauptsitzes der BAG durch die BAG-Partner
⇨ orientiert am Versorgungsschwerpunkt der BAG-Tätigkeit;
Wahl für zwei Jahre verbindlich; nur jeweils für den Beginn eines Quartals; Anzeigepflicht

- Wechselseitiges Arbeiten der Ärzte/ärztl.Therapeuten an allen Standorten möglich
- Pro Standort mindestens ein Vertragsarzt/ärztl.Therapeut
- auch KV – übergreifend möglich
- persönlich mind. 20 Std./Wo. in Form von Sprechstunden (bei Teilzulassung 10 Std.) am Vertragsarztsitz
- Tätigkeit am Vertragsarztsitz überwiegt insgesamt zeitlich vertragsärztlichen Tätigkeiten an weiteren Orten außerhalb des VA-Sitzes

Praxiserweiterung - Filiale



Keine Bedarfsprüfung mehr wie früher bei Zweigpraxis!

Zwar Gefahr des Drittwiderspruchs, aber ggf. keine aufschiebende Wirkung wg. „offensichtlicher Unzulässigkeit“ (vgl. BSG-Rechtsprechung)!

Voraussetzungen:

Versorgung an den **weiteren Orten** wird **objektiv verbessert**

Ordnungsgemäße Versorgung am Ort der **Stamm-Praxis nicht nur geringfügig beeinträchtigt**

Vorkehrungen für ordnungsgemäße **Versorgung an allen Orten** sind zu treffen (BayBO Ärzte)

Medizinisches Versorgungszentrum

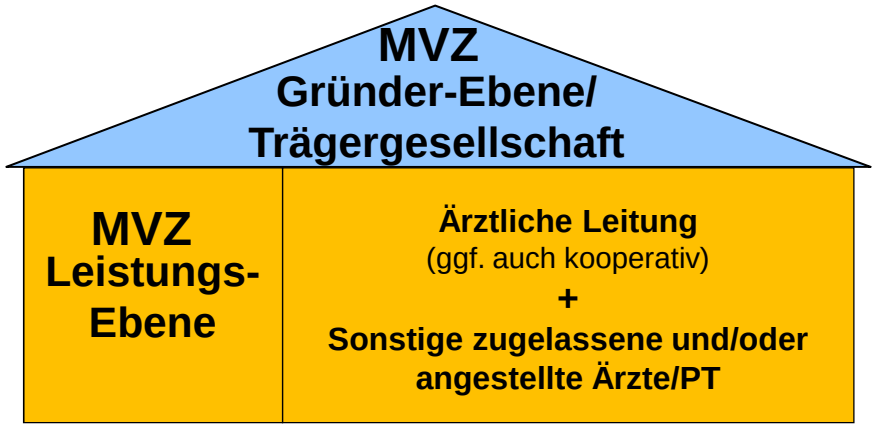
- unterliegt der Bedarfsplanung
- Zulassung durch Zulassungsausschuss
- zulässige Gründer:
  - zugelassene Ärzte/PT
  - zugelassene KH
  - Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen
  - gemeinnützige Träger (aufgrund Zulassung oder Ermächtigung)
  - Kommunen



Gründereigenschaft zugelassener Ärzte/PT kann auch bei Verzicht auf die Zulassung zum Zwecke der Anstellung im MVZ erhalten bleiben, solange diese im MVZ tätig und Gesellschafter des MVZ bleiben!

- zulässige Rechtsformen bei Gründung:
  - Personengesellschaft (GbR; PartG)
  - eingetragene Genossenschaft
  - GmbH
  - öffentlich-rechtliche Rechtsformen

- fachübergreifend oder (seit 01.08.2015) fachgleich auf der Leistungsebene; mind. 2 Ärzte mit AF 0,5
- ärztlich geleitet durch im MVZ tätigen VA (mind. Teilzulassung) oder angest. Arzt (mind. 20 Wo.Std.)
- Bestandsschutz bezügl. Gründer u. Rechtsformen für Alt-MVZ vor dem 01.01.2012



Vertragsarztrechtliche Bestimmungen für Ärzte/Psychotherapeuten gelten auch für die Medizinischen Versorgungszentren entsprechend!

Fotos: Getty Images

Zeitplan für Praxisübergabe/-übernahme

Langfristige Maßnahmen
ca. 2 - 3 Jahre vor Abgabetermin

- **Besuch Abgabeseminar**, Kontakt zu Referenten herstellen
- **Erstellung Abgabeplan/-konzept** (auch im Hinblick auf evtl. Einbringung in MVZ, Kooperation o.ä.)

hierzu kontaktieren

➢ **KVB**: Beratung wegen evtl. zulassungsrechtlicher Vorteile aus **Übergangs-Kooperationsformen** nach neuem Vertragsarztrecht / Mitarbeit eines Bewerbers in der Praxis etc.

➢ **Steuerberater (**ärztespezialisiert)**:** Prüfung steuerlicher und betriebswirtschaftlicher **Optimierungsmöglichkeiten**

➢ **Rechtsanwalt** (ärztespezialisiert): Überprüfung der **laufenden Praxisverträge** (Mietvertrag, evtl. Gesellschaftsvertrag, Arbeitsverträge etc.), rechtliche Rahmenbedingungen für ev. **Übergangskooperation** besprechen

➢ **Bank:** finanzielle **Ruhestandsplanung**/ Ermittlung der freien Liquidität im Alter

Mittelfristige Maßnahmen
ca. 1 - 2 Jahre vor Abgabetermin

- **Abgeber: „Schmücken der Braut“**, d.h. optische Verschönerung der Praxis
- **Abgeber:** Zusammenstellen der notwendigen **Verkaufsunterlagen** (Inventarliste, Garantieunterlagen, KV-Abrechnungen, Einnahmen-/ Überschussrechnungen, Verträge etc.)
- **Bank:** Abschätzen der erwerberseitigen **Finanzierbarkeit** des vom Verkäufer erwarteten Kaufpreises durch Einsatz der **Spezialsoftware** für Existenzgründer „INKO“
- **Rechtsanwalt (**ärztespezialisiert)**:** Erstellung **Vertragsrohentwurf** für Praxisübergabevertrag / Übergangsgemeinschaft
- **Abgeber** bzw. **professioneller Vermittler: Suche** nach **Übernahmeinteressenten** (ist auch über KVB möglich, Praxisbörse-Online)

Kurzfristige Maßnahmen
ca. 1 J. - 9 Mon. vor Abgabetermin

- **Sachverständiger bzw. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer**: ggf. **Praxisbewertung** / -schätzung in Auftrag geben
- **Rechtsanwalt** (ärztespezialisiert): **Praxisübergabevertrag** / Vertrag für Übergangsgemeinschaft erstellen bzw. für konkreten Übernehmer anpassen lassen
- **KVB: Antrag auf Zulassungsnachbesetzung** stellen (möglichst erst nach Unterzeichnung Praxisübergabevertrag, etc.)

Praxis und Partnersuche

Wie finde ich einen

- Kooperationspartner/Angestellten ?

- Abgeber?



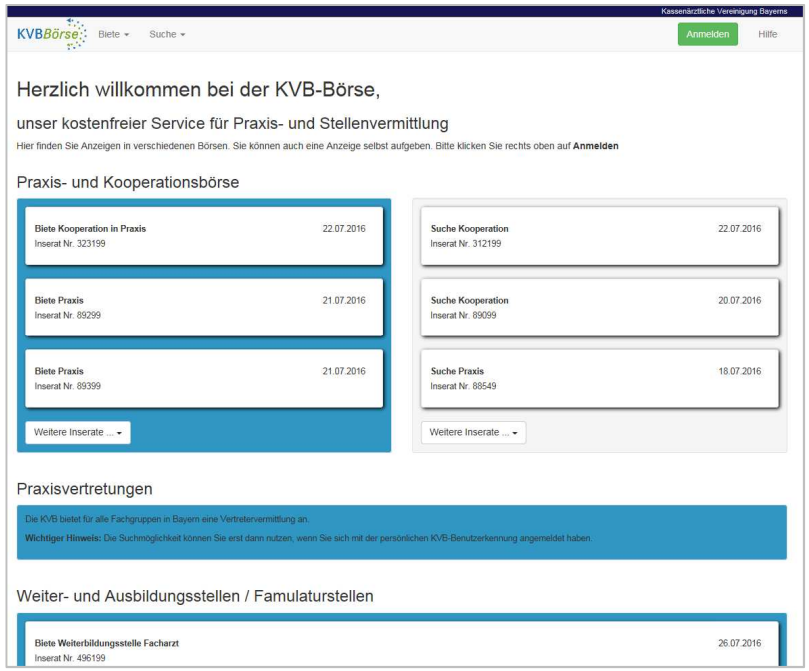
Foto: Getty Images



Foto: Jupiter Images Corporation

- Praxisbörse der KVB (online) – Praxisabgabe/Praxissuche
  (Kostenfreies Serviceangebot Ihrer KVB)
- sonstige überregionale Anbieter von (Internet-)Praxisbörsen
- Private Vermittler/Berater
- Deutsches Ärzteblatt / sonstige Fachzeitschriften
- Informationen aus dem Kollegenkreis
- Kooperationsbörse der KVB (online)
  → Partner/Angestellten suchen/finden

KVB-Börse - Praxisbörse



- ein kostenfreier Service der KVB
- diskret, vertraulich, neutral (bei uns sind keine Vermittlungsverträge notwendig oder Werbeattacken zu befürchten)
- Praxissuchende und Praxisabgeber erfassen ihre Anzeige in der KVB-Börse
  – Mit Kontaktdaten oder auf Wunsch als Chiffre-Anzeige
- Aktualisierung des Inserates jederzeit möglich
- Komfortable Suchmöglichkeiten
- Auch auf Tablet oder Smartphone nutzbar
- Aktualisierungsabfrage nach 5 Monaten

Die KVB-Börse finden Sie unter **www.kvb.de** in der Registerkarte *Online-Zugänge*

Genehmigungspflichtige vertragsärztliche Leistungen

Bestimmte vertragsärztliche Leistungen sind erst auf Antrag und **nach** Erteilung einer Genehmigung abrechnungsfähig (z.B. Röntgen, Sonographie, amb. OP)

Die Genehmigung ist vom Nachweis spezieller **fachlicher**, **apparativ-technischer**, **baulich-räumlicher**, **personeller** und/oder **organisatorischer** Voraussetzungen abhängig.

Die **vorherige** Genehmigungserteilung durch die KVB ist **zwingende** Voraussetzung für die Vergütung dieser Leistungen!

Achtung: Ein Wechsel des Teilnahmestatus macht Neuerteilung der Genehmigung erforderlich!



Foto: Getty Images

Zur Vermeidung von Honorarverlusten: Holen Sie möglichst frühzeitig Information über die jeweils notwendigen Voraussetzungen bei den Beratern ein!

Stellen Sie bereits mehrere Monate vor der geplanten Aufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit die Anträge!

Vertragsärztliche Pflichten

Nach Aufnahme der Tätigkeit zu beachtende vertragsärztliche Pflichten:

- **Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems für die Praxis gemäß § 135 a Abs. 2 SGBV**
  - vollständige Einführung innerhalb von 4 Jahren nach Aufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit bzw. fortlaufende Weiterentwicklung

- **Fortbildungsverpflichtung nach § 95 d SGB V**:
  - Nachweispflicht alle 5 Jahre über 250 Fortbildungspunkte; bei Nichterbringung drohen Honorarkürzungen



- **Teilnahme am vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 10 SGB V**
  - gilt grundsätzlich für alle zugelassenen Ärzte, ärztl. Psychotherapeuten und MVZ, soweit keine Ausnahmen in den Satzungen/Bereitschafts-dienstordnungen der KVen geregelt sind

Finanzielle Förderung der Niederlassung

Fördermaßnahmen gemäß der Sicherstellungsrichtlinie der KVB

- Regionale finanzielle Fördermaßnahmen, um (drohender) Unterversorgung oder einem zusätzlichen Versorgungsbedarf innerhalb eines Planungsbereichs entgegenzuwirken:
  1. Zuschuss für eine Niederlassung
  2. Praxisaufbauförderung
  3. Zuschuss für die Errichtung einer Zweigpraxis
  4. Zuschuss für die Beschäftigung eines angestellten Arztes/Psychotherapeuten
  5. Zuschuss für die Beschäftigung einer hausärztlichen Versorgungsassistentin bzw. Präventionsassistentin in der Kinder- und Jugendmedizin
  6. Zuschuss für die Fortführung einer Praxis über das 63. Lebensjahr hinaus

- Finanzielle Förderung unabhängig von Feststellungen des Landesausschusses:
  1. Finanzielle Förderung anerkannter Praxisnetze
  2. Finanzielle Förderung Methadonsubstitution

Ausführliche Details zu den einzelnen Fördermaßnahmen und den derzeit förderfähigen Planungsbereichen finden Sie unter:

www.kvb.de/praxis/niederlassung/finanzielle-foerdermoeglichkeiten/

KVB
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

